

17. DAS AUGE UND DIE BEWEGUNG DER KORTIKALISIERUNG

DAUER : 08:22

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video untersucht die dynamische Verbindung zwischen dem Auge und der Kortikalisierungsbewegung in der Gehirnentwicklung. Der Prozess der Kopf- und Halsbeugung wird ebenso untersucht wie die Reorganisation des Hirngewebes in Bezug auf Gesichts- und viszerale Strukturen. Das Auge wird als zentrale Akteurin in dieser Bewegung dargestellt, die die Bildung der Falx cerebri und des Tentorium cerebelli beeinflusst und gleichzeitig psychische und emotionale Aspekte durch ihre Verbindung zum Hormonsystem integriert. Die Konzepte des Gleichgewichtsdiaphragmas und des terminalen Fulkrums werden eingeführt, wobei die Bedeutung der Stabilisierung der Kreuznaht für die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Augen und die Förderung der körperlichen Harmonie hervorgehoben wird. Diese Lektion bietet praktische und theoretische Schlüssel für Praktiker, die die embryologische Entwicklung und ihre therapeutischen Implikationen besser verstehen möchten.

DAS AUGE UND DIE KORTIKALISATIONSBEWEGUNG

Das **Gehirn**, ursprünglich als flaches Gewebe wahrgenommen, durchläuft im Laufe seiner Entwicklung eine signifikante Transformation. Stellen Sie sich eine Person vor, die auf einem Tisch liegt, mit ihrem Gehirn in der Hand. Die erste Information, die man sich merken sollte, ist die der **Expansion** und der **Bildung des Neuralrohrs**.

Dieser Prozess beginnt mit einer **cephalen Flexionsbewegung**, gefolgt von einer **zervikalen Flexion**, dann einer **pontinen** Entwicklung und einem **Telencephalie**-Prozess. Während sich das Gehirn aufrichtet, folgen die kleinen Strukturen dieser Entwicklung, was auf eine Richtungsänderung hinweist.

Das **Auge** enthält in seiner Entwicklungsspirale die Information der **Kortikalisation**. Bei dieser Aufrichtung reorganisiert sich das gesamte Gewebe in einer Rotationsbewegung und nähert sich der **Mittellinie**. Unten zieht das Gewebe zum Herzen und zum Verdauungssystem, während es sich oben aufrichtet. Diese Bewegung wird durch den **Aufstieg des Gehirns** und den **Abstieg des kardio-viszeralen Systems** erzeugt.

Das Auge spielt eine entscheidende Rolle bei diesem Phänomen der **Kortikalisierung** und trägt zur Entwicklung der **Falx cerebri** und des **Tentorium cerebelli** bei, das sich an den Processus clinoidei ansetzt. In der Nähe befindet sich das **Chiasma opticum**, ein wesentliches Element, das berücksichtigt werden muss.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das **Gleichgewichtsdiaphragma** und die **Tonon-Kapsel**, die das Auge mit dem gesamten Gesichtssystem und allen Faszien des Körpers verbindet. Dies bedeutet, dass das Auge eine integrale **Einheit** darstellt, die alle Gesichtsinformationen enthält. Es empfängt auch emotionale und psychische Informationen, die durch hormonelle Substanzen vermittelt werden. Somit ist der psychische Zustand untrennbar mit einem hormonellen und emotionalen Zustand verbunden.

Das Auge zu behandeln bedeutet also, die Entwicklung sowohl **peritoneal**, **peripher** als auch **kortikal** anzugehen. Das Auge steht in Beziehung zur Gesamtheit des Körpers in seiner Expression und Entwicklung. Jedes Organ hat seinen eigenen Standpunkt, und jedes Organ ist ein Symbol.

Um den **26. Tag** herum erscheint eine **Augenfurche**, die mit einer internen Verbindung zusammenhängt. Diese Furche wird durch eine Vesikel stimuliert, die die oberflächliche Wand berührt. Die cephalische und zervikale Flexion führt zu einer Begegnung zwischen Gehirn und Herz, wobei sich das Auge auf dem Herzen ablegt. Dies erzeugt eine **hintere Falte**, bekannt als **pontine Krümmung**, wo sich das Sakrum und das Tentorium cerebelli befinden.

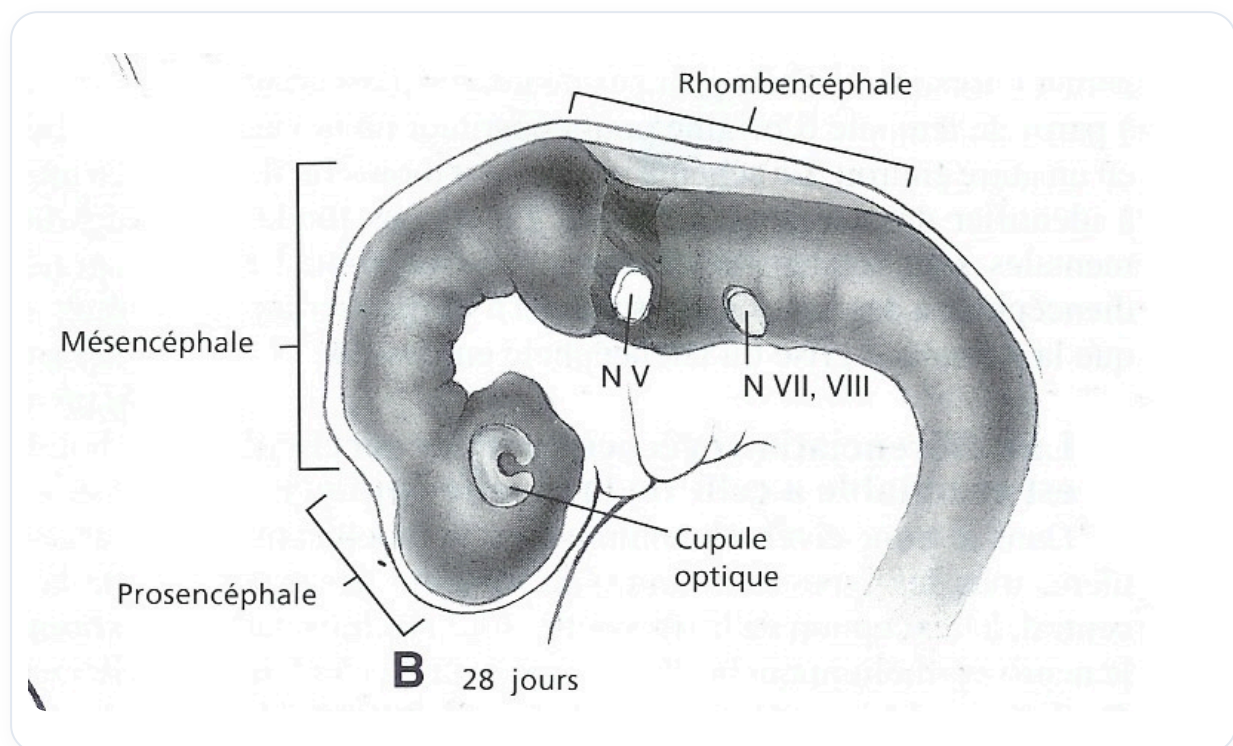


ABB. — Augenfurche und Blase

Das **Tentorium cerebelli** ist von größter Bedeutung, da es Synchronizitäten mit dem Peritoneum und dem Gehirn herstellt. Die **submesenzephalie Flexur** steht in Beziehung zur Spitze der **Chorda dorsalis** und dient als Stützpunkt. Das **Supraocciput** ist ebenfalls mit der zervikalen

Flexion verbunden, während die pontine Flexur mit der Schädelbasis assoziiert ist.

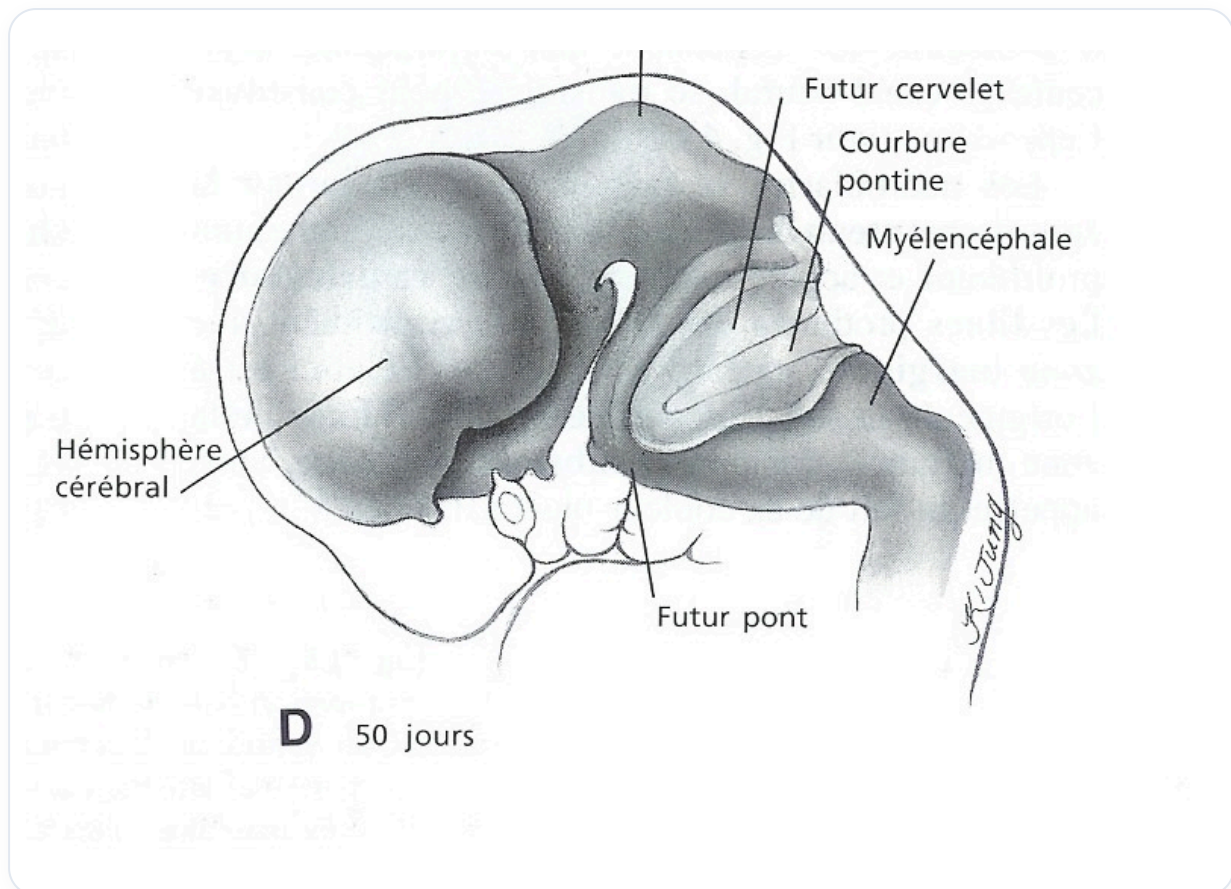


ABB. — Begegnung von Gehirn und Herz

Der Aufstieg des Neuralrohrs beeinflusst die Entwicklung des Verdauungs- und Herzsystems sowie anderer Entwicklungsräume. Die **Kolokalitäten** und **Synchronizitäten** während der Morphogenese helfen, die Stützpunkte zu verstehen. Der Aufstieg des **Ektoderms** und der Abstieg des **Endoderms** sind wesentlich für die Integration des Gehirns.

Das Auge folgt dieser Entwicklungsphase und nähert sich der Mittellinie, um die **Crista galli** zu bilden, die die Membranen vereint, um die Falx cerebri zu schaffen. Das Tentorium cerebelli entwickelt sich ebenfalls während des Pontisationsphänomens.

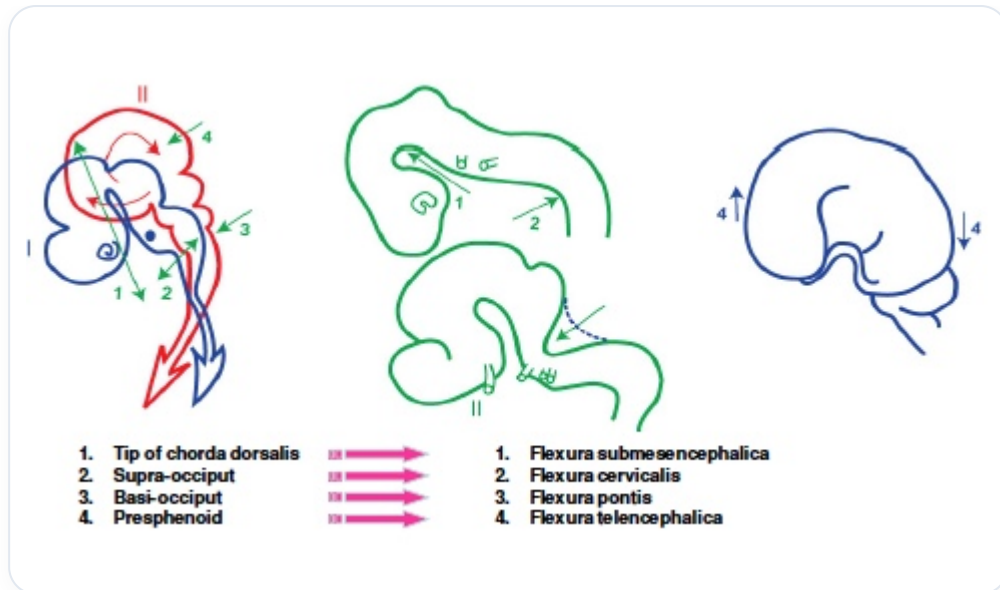


ABB. — Stützpunkte

Es ist entscheidend zu beachten, dass der Stützpunkt oder **terminale Fulcrum** der Augenpositionierung wesentlich ist. Um die Augen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wird empfohlen, einen Finger in den Mund zu legen, auf Höhe der kleinen **kreuzförmigen Naht**. Dies ermöglicht es den beiden Augen, ihren Raum zu finden, wenn sich diese Naht stabilisiert.

Der **Stirnrand**, der **Jochbeinrand** und der **Oberkieferrand** sind wichtige Stützpunkte. Das Auf- und Absteigen der Strukturen trägt zur Schließung der Mittellinie bei, was auch mit der Gaumenschließung zusammenhängt. Wenn der Gaumen seinen Stützpunkt findet, finden auch die Augen ihren Platz, was einen **Ankunftsfulcrum** in der Entwicklung markiert.